

Registro de Situaciones Ansiógenas

01

Técnica de automonitoreo

OBJETIVO

- Identificar los disparadores específicos de la ansiedad del paciente.
- Romper la automaticidad: hacer consciente lo que ocurre antes, durante y después.
- Proveer datos objetivos para la conceptualización del caso.

CUÁNDO USARLA

- Al inicio del tratamiento para mapear el perfil de ansiedad.
- Cuando el paciente no puede identificar sus disparadores con claridad.
- Como tarea entre sesiones para recolectar información contextual.

PASO A PASO

- 1 Describir la situación: ¿dónde, cuándo, con quién?
- 2 Registrar el nivel de ansiedad del 0 al 10 antes y después.
- 3 Anotar el pensamiento automático que apareció.
- 4 Describir qué hizo el cuerpo (síntomas físicos).
- 5 Registrar la conducta: ¿qué hizo o dejó de hacer?

NOTAS CLÍNICAS

- Buscar patrones: ¿hay situaciones, personas o momentos recurrentes?
- Evaluar si la ansiedad es difusa (generalizada) o situacional.
- El registro en sí mismo ya es una intervención — aumenta la distancia observacional.

Respiración Diafragmática

02

Técnica de regulación fisiológica

OBJETIVO

- Activar el sistema nervioso parasimpático para reducir la activación.
- Interrumpir el ciclo: ansiedad → hiperventilación → más ansiedad.
- Dar al paciente una herramienta de autorregulación inmediata.

CUÁNDO USARLA

- En crisis de ansiedad o pánico agudo.
- Como práctica preventiva diaria.
- Antes de situaciones de exposición identificadas como disparadoras.

PASO A PASO

- 1 Posición cómoda. Una mano en el pecho, otra en el abdomen.
- 2 Inspirar lento por la nariz contando 4 tiempos. Solo debe moverse el abdomen.
- 3 Sostener el aire 2 tiempos.
- 4 Exhalar lento por la boca contando 6 tiempos. Abdomen desciende.
- 5 Repetir entre 5 y 10 ciclos. Practicar 2 veces por día fuera de crisis.

NOTAS CLÍNICAS

- Enseñar la técnica en sesión y practicarla juntas antes de asignarla.
- Aclarar: no elimina la ansiedad, baja la activación fisiológica.
- En pánico: puede sentirse peor al inicio — anticipar y normalizar.

Reestructuración del Pensamiento Catastrófico

03

Técnica cognitiva

OBJETIVO

- Identificar y cuestionar la distorsión cognitiva central en la ansiedad.
- Reemplazar predicciones catastrofistas por evaluaciones realistas.
- Aumentar la tolerancia a la incertidumbre.

CUÁNDO USARLA

- Cuando el paciente anticipa el peor resultado como inevitable.
- En ansiedad generalizada, fobia social y trastorno de pánico.
- Una vez que hay registro ABC consolidado como base.

PASO A PASO

- 1 Identificar el pensamiento catastrófico: ¿cuál es el peor escenario?
- 2 Evaluar probabilidad real: ¿qué tan probable es del 0 al 100?
- 3 Buscar evidencia a favor y en contra del pensamiento.
- 4 Generar un pensamiento alternativo más realista y equilibrado.
- 5 Evaluar cómo cambia la ansiedad con el pensamiento alternativo.

NOTAS CLÍNICAS

- No se trata de pensar positivo — se trata de pensar con evidencia.
- Usar el diálogo socrático, no confrontar directamente la creencia.
- Combinada con exposición es más potente que usada sola.

Exposición Gradual

04

Técnica conductual — primera línea en ansiedad

OBJETIVO

- Romper el ciclo de evitación que mantiene y amplifica la ansiedad.
- Generar habituación y aprendizaje de seguridad ante el estímulo.
- Demostrar al paciente que puede tolerar el malestar sin que ocurra la catástrofe.

CUÁNDO USARLA

- En fobias específicas, fobia social, agorafobia, TOC.
- Cuando la evitación está claramente manteniendo el problema.
- Después de psicoeducación y entrenamiento en regulación.

PASO A PASO

- 1 Construir la jerarquía de exposición: listar situaciones de menor a mayor ansiedad.
- 2 Asignar un valor del 0 al 100 a cada situación (SUDS).
- 3 Comenzar por situaciones con valor 20-30 — nunca por las más altas.
- 4 Mantenerse en la situación hasta que la ansiedad baje al menos un 50%.
- 5 Registrar nivel de ansiedad antes, durante y después de cada exposición.

NOTAS CLÍNICAS

- La exposición sin evitación cognitiva ni conductual es lo que produce el cambio.
- No avanzar en la jerarquía hasta consolidar el escalón anterior.
- Anticipar el aumento inicial de ansiedad: es parte del proceso, no una señal de fracaso.

Grounding 5-4-3-2-1

05

Técnica de anclaje sensorial

OBJETIVO

- Interrumpir la espiral ansiosa y devolver al paciente al momento presente.
- Activar los sentidos como ancla cuando el pensamiento se anticipa al futuro.
- Técnica de fácil aplicación autónoma en situaciones de alta activación.

CUÁNDO USARLA

- En crisis de ansiedad o pánico agudo.
- Cuando hay disociación leve o sensación de irrealidad.
- Como primer paso antes de aplicar técnicas cognitivas.

PASO A PASO

- 1 5 cosas que podés VER ahora mismo. Nombrártelas internamente.
- 2 4 cosas que podés TOCAR. Hacerlo físicamente y registrar la textura.
- 3 3 cosas que podés OÍR en este momento.
- 4 2 cosas que podés OLER o tu olor favorito si no hay nada presente.
- 5 1 cosa que podés SABOREAR o el sabor que preferís.

NOTAS CLÍNICAS

- Practicarla en sesión antes de que la necesiten en crisis.
- Útil también en disociación y en trauma — no solo en ansiedad.
- Puede combinarse con respiración diafragmática como protocolo de crisis.

Registro de Evitaciones

06

Técnica de automonitoreo conductual

OBJETIVO

- Hacer visible el patrón de evitación que el paciente generalmente no registra.
- Mapear el costo real de evitar: qué actividades, vínculos o metas está perdiendo.
- Generar motivación para la exposición gradual.

CUÁNDO USARLA

- Cuando el paciente minimiza el impacto de la ansiedad en su vida.
- Como paso previo a construir la jerarquía de exposición.
- En ansiedad social, agorafobia y fobias donde la evitación es extensa.

PASO A PASO

- 1 Listar durante una semana todo lo que evitó por ansiedad.
- 2 Clasificar cada evitación: situación, persona, pensamiento o sensación.
- 3 Registrar qué alivio trajo a corto plazo.
- 4 Registrar qué costo tuvo a mediano plazo.
- 5 Evaluar: ¿qué vida tendría si no evitara estas situaciones?

NOTAS CLÍNICAS

- La evitación es el mantenedor principal de la ansiedad — centrarlo en psicoeducación.
- Incluir evitaciones sutiles: revisar el teléfono, buscar reaseguro, llegar temprano.
- El contraste corto plazo/mediano plazo suele ser el mayor motivador para el cambio.

Relajación Muscular Progresiva

07

Técnica de regulación somática

OBJETIVO

- Reducir la tensión muscular crónica asociada a la ansiedad.
- Desarrollar conciencia corporal y discriminación entre tensión y relajación.
- Herramienta de práctica preventiva para bajar el nivel basal de activación.

CUÁNDO USARLA

- En ansiedad generalizada con tensión muscular persistente.
- Como práctica preventiva diaria — no solo en crisis.
- Complementaria a la respiración diafragmática.

PASO A PASO

- 1 Posición cómoda, ojos cerrados. Ambiente sin distracciones.
- 2 Comenzar por los pies: tensar 5 segundos, soltar y registrar la diferencia.
- 3 Subir progresivamente: pantorrillas, muslos, abdomen, manos, brazos, hombros, cara.
- 4 En cada grupo muscular: tensión (5 seg) → soltar → observar (15 seg).
- 5 Finalizar con respiración lenta y escaneo corporal completo.

NOTAS CLÍNICAS

- Requiere práctica regular — el efecto se consolida con el tiempo, no en una sesión.
- Grabar el audio de la técnica guiada para que el paciente la use en casa.
- En pacientes con trauma: introducir con cuidado — la atención al cuerpo puede activar.

Plan de Acción ante Crisis de Ansiedad

08

Protocolo de manejo de crisis

OBJETIVO

- Dar al paciente una guía clara y personalizada para momentos de alta activación.
- Reducir el miedo al miedo: saber qué hacer disminuye la intensidad de la crisis.
- Construir autonomía progresiva en el manejo de su ansiedad.

CUÁNDO USARLA

- Con cualquier paciente que tenga crisis de ansiedad o pánico.
- Se construye en sesión y se le entrega por escrito.
- Se revisa y ajusta según la experiencia del paciente con el plan.

PASO A PASO

- 1 RECONOCER: 'Esto es una crisis de ansiedad. No es peligroso. Va a pasar.'
- 2 PARAR: detenerse, no huir de la situación si es posible.
- 3 RESPIRAR: aplicar respiración diafragmática — inspirar 4, sostener 2, exhalar 6.
- 4 ANCLAR: aplicar grounding 5-4-3-2-1 para volver al presente.
- 5 EVALUAR: cuando la activación baja, identificar el disparador y registrarlo.

NOTAS CLÍNICAS

- El plan se construye CON el paciente — no se le entrega uno genérico.
- Incluir una frase de autoafirmación personalizada en el paso 1.
- Revisar el plan después de cada crisis: ¿qué funcionó? ¿qué hay que ajustar?